

Tạo hình bể thận

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật sửa chỗ tắc nghẽn nơi thận dẫn lưu

WARWIKI

Tạo hình bể thận (pyeloplasty) là phẫu thuật sửa chỗ tắc nghẽn tại chỗ nối bể thận-niệu quản (UPJ) — nơi thận thông xuống ống dẫn nước tiểu đến bàng quang. Khi chỗ nối này bị hẹp, nước tiểu ứ lại gây đau, nhiễm trùng hoặc tổn thương thận. Phẫu thuật cắt bỏ đoạn hẹp và nối lại rộng rãi, thông thoáng — tỉ lệ thành công trên 90%.

Về ca phẫu thuật này

Tại đầu trên niệu quản, chỗ nối với **bể thận** (túi chứa nước tiểu của thận), đôi khi có đoạn hẹp làm chậm dẫn lưu. Đôi khi một **mạch máu** chèn ép từ bên ngoài. Tình trạng này gọi là **tắc nghẽn UPJ**. Trong phẫu thuật, bác sĩ sẽ:

- Cắt bỏ đoạn hẹp
- Khâu nối niệu quản lành với bể thận tạo **chỗ nối rộng hình phễu**
- Đặt một **ống thông JJ (stent)** bên trong để giữ chỗ nối mở trong lúc lành

Thường được thực hiện bằng **robot hoặc nội soi** qua vài vết rạch nhỏ; đôi khi qua một vết mổ mở.

Có an toàn không?

Đây là phẫu thuật được thực hiện phổ biến và hiệu quả lâu dài, tỉ lệ thành công trên 90%. Như mọi phẫu thuật, có thể xảy ra một số nguy cơ — chảy máu, nhiễm trùng, hoặc rò nước tiểu tạm thời (thường được kiểm soát bằng stent và ống dẫn lưu). Tái hẹp ít gặp và thường xử lý được.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Thận

Cơ quan lọc máu và tạo ra nước tiểu.

Niệu quản

Ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang.

UPJ

Chỗ nối bể thận-niệu quản — vị trí thận nối với niệu quản; là chỗ bị tắc.

Bể thận

Túi hình phễu thu nước tiểu trước khi vào niệu quản.

Ống thông JJ (stent)

Ống nhỏ mềm đặt bên trong giữ chỗ nối mở trong lúc lành.

Mạch máu chèn ép

Mạch máu có thể đè lên chỗ nối gây tắc nghẽn.

Ứ nước thận

Thận phình to do nước tiểu ứ lại phía sau chỗ tắc.

Phẫu thuật robot / nội soi

Mổ qua vài vết rạch nhỏ.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, bạn có thể đau nhức tại các vết rạch nhỏ và đôi khi khó chịu ở vai hoặc bụng do khí dùng trong phẫu thuật nội soi. Ống thông JJ bên trong có thể gây tiểu gấp hoặc đau tức nhẹ vùng hông khi đi tiểu. Hầu hết bệnh nhân nằm viện 1–2 ngày; phẫu thuật thường kéo dài 2–3 giờ.

Cách chuẩn bị (Trước phẫu thuật)

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân** — làm theo mọi hướng dẫn (nhịn ăn và các thuốc cần ngừng, kể cả thuốc loãng máu).
- Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng — nếu có nhiễm trùng phải điều trị trước.
- Dự kiến có **ống thông JJ trong khoảng 4–6 tuần** và nhờ người đưa về sau mổ.

Hãy báo với nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc loãng máu** hoặc có nhiễm trùng nước tiểu hiện tại
- Đã từng phẫu thuật thận hoặc bụng trước đây

Quá trình phẫu thuật

- Bạn được gây mê toàn thân và dùng kháng sinh.
- Bác sĩ rạch vài vết nhỏ (hoặc một vết mổ mở) để tiếp cận chỗ nối bị tắc.
- Cắt bỏ đoạn hẹp và tạo hình lại bể thận.
- Khâu nối niệu quản lành với bể thận thành hình phễu rộng trên ống thông JJ; có thể đặt ống dẫn lưu nhỏ rồi đóng vết mổ.

Sau phẫu thuật

- Thường về nhà sau **một hoặc hai ngày**.
- Ống thông JJ ở trong khoảng 4–6 tuần**, sau đó được lấy ra qua nội soi bàng quang tại phòng khám.
- Các triệu chứng do ống thông JJ — tiểu gấp, đau tức nhẹ vùng hông khi tiểu, hoặc nước tiểu hồng — là **bình thường**.
- Tránh nâng vật nặng và rặn sức** trong vài tuần; uống nhiều nước.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Đau hông hoặc bụng nặng hoặc ngày càng tăng
- Chảy máu nhiều hoặc có cục máu trong nước tiểu
- Không thể đi tiểu, hoặc buồn nôn/nôn kéo dài
- Vết mổ ngày càng đỏ, đau hoặc chảy dịch

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Tạo hình bể thận loại bỏ chỗ tắc và tạo chỗ nối rộng — phương pháp lâu dài nhất, thường qua vài vết rạch nhỏ.
- Chuẩn bị: làm theo hướng dẫn nhịn ăn và thuốc, điều trị nhiễm trùng trước, dự kiến ống thông JJ khoảng 4–6 tuần, nhờ người đưa về.
- Ống thông JJ có thể gây tiểu gấp hoặc đau tức nhẹ cho đến khi lấy ra tại phòng khám. Gọi ngay nếu sốt, đau nặng, chảy máu nhiều hoặc không đi tiểu được.